Masterprompt:

Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von Akzeptanz von KI-gestützten Systemen bei medizinischen Behandlungen bei Patientinnen und Patienten. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.
Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme bei der eigenen Behandlung. Gemessen werden die Nutzungsabsicht und die Faktoren, die sie beeinflussen.
Arbeitsschritte
Arbeite diese Schritte der Reihe nach ab:

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien und begründe die Wahl.
2. Modell: Leite ein Modell ab. Formuliere jeden Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese mit Richtung (+/−) und Quelle. Die Richtung stammt aus der in der Quelle formulierten Hypothese, nicht aus dem empirischen Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf.
4. Items: Erstelle je Konstrukt 3 bis 5 Items.

Theorievergleich
Liste in Schritt 1 alle Theorien aus den Quellen auf. Prüfe für jede, wie gut sie zur Zielgröße passt, und begründe, warum du sie aufnimmst oder nicht. Gib den Vergleich unter „Theorie und Begründung“ aus.
Konstrukttreue
Übernimm Konstrukte so, wie die Quelle sie misst. Getrennt gemessene Konstrukte oder Unterdimensionen bleiben getrennt, keine Sammelkonstrukte. Lass kein Konstrukt einer aufgenommenen Theorie ohne Begründung weg. Neu formulierte Items fragen genau einen Sachverhalt ab.
Perspektive
Formuliere alle Items in der Ich-Form und bezogen auf sich selbst, nicht aus Sicht der Organisation (z. B. „wir“, „unser Unternehmen“).
Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, deren Itemtexte in den Quellen abgedruckt sind. Ein Verweis wie „Items adaptiert aus …“ zählt nicht. Anpassen darfst du nur Gegenstand, Perspektive und Sprache. Übersetze sinngleich ins Deutsche. Sonst bleibt der Wortlaut gleich: nichts hinzufügen, nichts weglassen, nichts zusammenlegen. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl. Verwende für den Gegenstand überall dieselbe Bezeichnung. Quelle je Item: Fragebogen oder Paper und Item-Kennung, nur wenn sie in der Quelle steht. Erfinde keine Kennungen. Kein Originaltext. Itemzahl je Skala: 3–5 Items: alle. Mehr als 5: die ersten 5. Weniger als 3: alle, mit neu formulierten auf 3 auffüllen. Keine passende Skala: Items neu formulieren. Markierungen: „neu formuliert“ (ohne Quelle); „(übersetzt)“ nur bei übersetztem abgedrucktem Itemtext; „(invers)“ nur, wenn das Item in der Originalskala negativ formuliert ist. Prüfe vor der Ausgabe: Steht der Originalwortlaut jedes Items mit Quelle in den Quellen? Wenn nicht, markiere es als „neu formuliert“. Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.
Ausgabeformat
Gib nur diese vier Teile in dieser Reihenfolge aus, sonst nichts:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Tabelle: Konstrukt | Item | Antwortskala, ein Item pro Zeile

Ausgabelänge
Nenne die Antwortskala einmal über der Tabelle, die Spalte Antwortskala entfällt. Begründe jede Theorie in höchstens zwei Sätzen. Kürze bei Bedarf Begründungen, nie Konstrukte oder Items.

Response:

1. Theorie und Begründung

- Health Belief Model (HBM): Das HBM erklärt gesundheitsbezogenes Verhalten durch wahrgenommene Bedrohungen und den Nutzen von Präventionsmaßnahmen, vernachlässigt jedoch spezifische technologische Akzeptanzfaktoren von Informationssystemen[1][2]. Es wird daher nicht als alleinige Theorie gewählt, geht aber als wesentlicher Baustein in das integrierte Modell ein[3][4].
- Protection Motivation Theory (PMT): Die PMT erfasst über den Dualitätsansatz sowohl krankheitsbezogene Bedrohungseinschätzungen als auch kognitive Bewältigungseinschätzungen, greift bei rein technologiebezogenen Einstellungen jedoch zu kurz[3]. Sie bildet das primäre gesundheitsbezogene Fundament für die nicht-adaptiven und adaptiven Bewertungen im gewählten Modell[3][7].
- Extended Parallel Process Model (EPPM): Das EPPM erweitert die PMT um die Differenzierung zwischen kognitiver Gefahrenabwehr und emotionaler Furchtabwehr, erfasst aber die Akzeptanz digitaler Systeme nicht vollständig[5][8]. Es wird als ergänzender Baustein zur Erklärung emotionaler Prozesse (Furcht) im integrierten Modell berücksichtigt[6][8].
- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) / TAM: UTAUT2 bietet fundierte Konstrukte zur Messung technologischer Akzeptanz (z. B. Effizienz, Leistungs- und Aufwandserwartung), ignoriert jedoch krankheitsspezifische Bedrohungswahrnehmungen von Patientinnen und Patienten[5][9]. Es wird zur Abbildung der technologiebezogenen Bewertung in das Modell integriert[4][9].
- Reasoned Action Approach (RAA) / TPB: Die RAA erklärt Verhaltensabsichten präzise durch Einstellungen, wahrgenommene Normen und Verhaltenskontrolle, beinhaltet jedoch keine spezifischen Konstrukte für medizinische Risiken oder KI-Eigenschaften[9][10]. Seine Konstrukte bilden die psychologische Basis der Absichtsbildung im integrierten Modell[4][11].
- Integriertes theoretisches Modell (Wichmann et al., 2024): Dieses Modell vereint HBM, PMT, EPPM, UTAUT2 und RAA in einem systematischen Dualitätsansatz, der krankheitsbezogene (nicht-adaptive) und technologiebezogene (adaptive) Bewertungen zur Erklärung der Nutzungsabsicht kombiniert[3]. Es wird als Gesamtrahmen gewählt, da es die Zielgröße der KI-Akzeptanz bei eigenen medizinischen Behandlungen am umfassendsten und mit hoher Erklärungskraft abbildet[12].

---

2. Modell mit Hypothesen

- H1a: Wahrgenommene Bedrohung → Furcht (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[15]

- H1b: Wahrgenommene Bedrohung → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[15]
- H2a: Nicht-adaptive Belohnungen → Furcht (Krankheit) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[15]
- H2b: Nicht-adaptive Belohnungen → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[15]
- H3: Furcht (Krankheit) → Einstellung (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[16]
- H4: Einstellung (Krankheit) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[16]
- H5a: Wahrgenommene Effizienz → Furcht (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[17]
- H5b: Wahrgenommene Effizienz → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[17]
- H5c: Wahrgenommene Effizienz → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[17]
- H6: Furcht (KI-System) → Einstellung (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[17]
- H7: Einstellung (KI-System) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[18]
- H8a: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Bedrohung (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H8b: Wahrgenommene Normen → Furcht (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H8c: Wahrgenommene Normen → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H8d: Wahrgenommene Normen → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H8e: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Effizienz (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H8f: Wahrgenommene Normen → Einstellung (Krankheit) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H8g: Wahrgenommene Normen → Furcht (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H8h: Wahrgenommene Normen → Nicht-adaptive Belohnungen (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H9a: Fähigkeiten bezüglich KI-System → Wahrgenommene Effizienz (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H9b: Fähigkeiten bezüglich KI-System → Furcht (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H9c: Fähigkeiten bezüglich KI-System → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H9d: Fähigkeiten bezüglich KI-System → Wahrgenommene Kosten/Barrieren (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H9e: Fähigkeiten bezüglich KI-System → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H10a: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Wahrgenommene Effizienz (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[20]

- H10b: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Einstellung (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[20]
- H10c: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[20]

---

3. Liste der Konstrukte

1. Wahrgenommener Schweregrad (Perceived severity): Formatives Konstrukt / Unterdimension der krankheitsbezogenen Bedrohungseinschätzung bezüglich der gesundheitlichen Konsequenzen[6][21].
2. Wahrgenommene Verwundbarkeit (Perceived vulnerability): Formatives Konstrukt / Unterdimension der krankheitsbezogenen Bedrohungseinschätzung bezüglich der persönlichen Erkrankungswahrscheinlichkeit[2][21].
3. Nicht-adaptive Belohnungen (Nonadaptive rewards): Wahrgenommene Vorteile oder Belohnungen durch das Beibehalten des aktuellen Verhaltens ohne KI-System[2][22].
4. Furcht bezüglich der Krankheit (Fear - Disease): Ausmaß der emotionalen Angst im Hinblick auf die eigene Erkrankung[2][23].
5. Einstellung gegenüber der Krankheit (Attitude - Disease): Haltung und emotionale/kognitive Bewertung der eigenen Erkrankung[23][24].
6. Wahrgenommene Reaktionswirksamkeit (Perceived response efficacy): Reflektive Unterdimension der wahrgenommenen Effizienz bezüglich der medizinischen Wirksamkeit des KI-Systems[9][23].
7. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived behavioral control): Reflektive Unterdimension der wahrgenommenen Effizienz bezüglich der Handlungsfreiheit und Ressourcen bei der Nutzung[9][23].
8. Wahrgenommene Normen (Perceived norms): Wahrgenommener sozialer Druck und Erwartungen relevanter Bezugspersonen bezüglich der Nutzung[9][25].
9. Furcht bezüglich des KI-Systems (Fear - HIS): Emotionale Angst oder Unsicherheit im Hinblick auf den Einsatz des KI-Systems bei der Behandlung[11][25].
10. Einstellung gegenüber dem KI-System (Attitude - HIS): Allgemeine positive oder negative Haltung gegenüber der Nutzung des KI-Systems[11][25].
11. Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems (Abilities - HIS): Einschätzung der eigenen Fertigkeiten und des Verständnisses im Umgang mit dem KI-System[19][26].
12. Wahrgenommene Kosten/Barrieren bezüglich des KI-Systems (Perceived costs/barriers - HIS): Wahrgenommene Hürden, Aufwände oder Belastungen durch die Nutzung des KI-Systems[20][23].
13. Nutzungsabsicht (Intention to use): Absicht der Patientin / des Patienten, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei der eigenen Behandlung einzusetzen (Zielgröße)[11][12].

---

4. Fragebogen

Antwortskala: 7-stufige Likert-Skala (1 = „stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 = „stimme voll und ganz zu“)

Konstrukt	Item	Quelle
Wahrgenommener Schweregrad	Wenn ich an meine Erkrankung denke, befürchte ich schwerwiegende gesundheitliche Folgen für mich.	neu formuliert
Wahrgenommener Schweregrad	Eine Verschlechterung meiner Erkrankung würde mein tägliches Leben stark beeinträchtigen.	neu formuliert

Wahrgenommener Schweregrad	Ich schätze die gesundheitlichen Auswirungen meiner Erkrankung als gravierend ein.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich halte mein persönliches Risiko für hoch, von gesundheitlichen Problemen betroffen zu sein.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich schätze die Wahrscheinlichkeit als hoch ein, dass sich meine Erkrankung ohne Behandlung verschlechtert.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich fühle mich anfällig für Komplikationen im Zusammenhang mit meiner Erkrankung.	neu formuliert
Nicht-adaptive Belohnungen	Es ist für mich bequemer, meine bisherige Behandlung ohne neue Systeme fortzusetzen.	neu formuliert
Nicht-adaptive Belohnungen	Die Beibehaltung meiner aktuellen Behandlungsform gibt mir ein Gefühl von Vertrautheit.	neu formuliert
Nicht-adaptive Belohnungen	Ich sehe für mich persönliche Vorteile darin, bei meinen gewohnten Behandlungsabläufen zu bleiben.	neu formuliert
Furcht bezüglich der Krankheit	Der Gedanke an meine Erkrankung macht mir Angst.	neu formuliert
Furcht bezüglich der Krankheit	Ich empfinde Furcht, wenn ich an mögliche Verschlechterungen meiner Erkrankung denke.	neu formuliert
Furcht bezüglich der Krankheit	Meine Erkrankung löst bei mir ein Gefühl der Beunruhigung aus.	neu formuliert
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich stehe meiner Erkrankung mit einer aktiven Haltung gegenüber.	neu formuliert
Einstellung gegenüber der Krankheit	Für mich ist es wichtig, mich intensiv mit meiner Erkrankung auseinanderzusetzen.	neu formuliert
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich betrachte den Umgang mit meiner Erkrankung als eine Aufgabe, die ich positiv angehen möchte.	neu formuliert
Wahrgenommene Reaktionswirksamkeit	Ich glaube, dass ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem meine medizinische Behandlung verbessert.	neu formuliert
Wahrgenommene Reaktionswirksamkeit	Der Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems ist effektiv zur Behandlung meiner Erkrankung.	neu formuliert
Wahrgenommene Reaktionswirksamkeit	Ich gehe davon aus, dass mir ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem gesundheitliche Vorteile bringt.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich habe die volle Kontrolle darüber, ob ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem nutze.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Es liegt ganz bei mir, mich für ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem zu entscheiden.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich besitze die Möglichkeiten, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung einzusetzen.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Personen, die mir wichtig sind, befürworten die Nutzung eines KI-gestützten	neu

	Gesundheitsinformationssystems durch mich.	formuliert
Wahrgenommene Normen	Mein behandelnder Arzt unterstützt es, dass ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem verwende.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	In meinem Umfeld wird erwartet, dass ich moderne KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme nutze.	neu formuliert
Furcht bezüglich des KI-Systems	Die Vorstellung, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung einzusetzen, macht mir Angst.	neu formuliert
Furcht bezüglich des KI-Systems	Ich empfinde Unbehagen beim Gedanken an den Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems.	neu formuliert
Furcht bezüglich des KI-Systems	Die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems löst bei mir Befürchtungen bezüglich möglicher Behandlungsfehler aus.	neu formuliert
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich halte den Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung für eine gute Idee.	neu formuliert
Einstellung gegenüber dem KI-System	Für mich ist die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems etwas Positives.	neu formuliert
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich stehe dem Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems aufgeschlossen gegenüber.	neu formuliert
Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems	Ich traue mir zu, die Funktionsweise eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems schnell zu verstehen.	neu formuliert
Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems	Ich besitze die notwendigen Kenntnisse, um ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bedienen zu können.	neu formuliert
Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems	Ich fühle mich fähig, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung korrekt anzuwenden.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten/Barrieren	Ich befürchte, dass der Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems für mich mit hohem Aufwand verbunden ist.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten/Barrieren	Ich sehe organisatorische Hürden bei der Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten/Barrieren	Die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems ist für mich mit finanziellen oder zeitlichen Belastungen verbunden.	neu formuliert
Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner zukünftigen Behandlung zu nutzen.	neu formuliert
Nutzungsabsicht	Ich werde mich dafür entscheiden, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem für meine Behandlung	neu formuliert

	einzusetzen.	
Nutzungsabsicht	Ich plane, bei anstehenden medizinischen Entscheidungen auf ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem zurückzugreifen.	neu formuliert